

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	新生兒黃疸 Neonatal Jaundice				
編號	A31000-Q03-W-N05	制定者	IR 黃淑媛	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 09 月 05 日
版本/總頁數	第 3.6 版/6 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解新生兒黃疸的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部新生兒科單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

1.生理性黃疸

新生兒紅血球較成人多（因此紅血球代謝後廢物較多），而且肝臟較不成熟（因此膽紅素較不易排出），所以比較容易產生黃疸。這種因生理現象導致的黃疸稱為「生理性黃疸」。一般嬰兒在出生第二-三天開始就會有生理性黃疸的出現，第四-五天達到最高峰（最黃），1-2 星期後逐漸消退。生理性黃疸的黃疸指數通常小於 12，除了皮膚、眼白泛黃外，無其他症狀，通常不需治療就會消退。

2.病理性黃疸

通常出生後 24 小時內出現黃疸、總膽紅素每日增加超過 5mg/dl、足月兒超過 15mg/dl，早產兒超過 13mg/dl，直接膽紅素超過 1.5-2mg/dl、足月兒黃疸超過一週，早產兒黃疸超過兩週，均可視為病理性黃疸。病理性黃疸的黃疸指數通常大於 15，不但需要治療，而且若不注意有可能導致嚴重的後果，如核黃疸。

主題名稱	新生兒黃疸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/6

（二）症狀

初期時，活力降低、不吃奶、哭聲改變、疲倦或躁動、忘記呼吸等情形。若血中膽紅素濃度持續上升，會出現四肢僵直、高而尖銳的哭聲，甚至抽筋。幾個月後，會呈現肌肉張力異常、智能障礙、痙攣、手足搐動症等現象，聽力異常也是常見的後遺症。

（三）常見檢查

病理性黃疸現象做血液的檢驗包括：結合型膽紅素值與總膽紅素值、母親與小孩的血型、有無引起溶血的抗體、血紅素值、血比容、紅血球型態、網狀紅血球值、白血球計數，以及 G-6-P-D 濃度。若有發燒、活動力不佳等狀況，則要做血液、尿液及腦脊髓液的培養，以確認是否有感染的情形。

延遲性黃疸為黃疸超過兩星期，需評估是否有肝膽及新陳代謝內分泌方面的問題，檢查項目包括：腹部超音波檢查、肝功能檢查、病毒血清檢查及培養、甲狀腺功能檢查、尿液檢查及膽道同位素檢查等。有時需進行肝臟穿刺以做切片檢查，來確認肝臟的病變為何。

（四）常見治療

1. 照光治療

利用光線的照射，使膽紅素的結構改變，變成高水溶性的物質，不需再經肝細胞的進一步代謝，即可由尿液及膽汁中排出。在特定光譜內(430-490nm)，以藍光的效果最好，維持一定強度，保持光源與小寶寶間一定的距離，注意保護眼睛及生殖器避免受強光傷害。

以藍光（光譜 425-457nm）使未接合膽紅素變成無毒性之異構物排出體外，也可加強照光(double phototherapy)，通常出生 24-48 小時內膽紅素超過 12mg/dl，出生 49-72 小時內超過 14mg/dl，出生 72 小時後超過 15mg/dl，須照光治療。

2. 藥物治療

巴比妥鹽類藥物可促進膽紅素的結合與排泄，促進黃疸改善，但此藥物有鎮靜的副作用，且效果不如照光治療，故不被建議常規用來治療新生兒黃疸。

主題名稱	新生兒黃疸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/6

3.交換輸血：當出生 24-48 小時內膽紅素超過 20mg/dl 或出生 48 小時後膽紅素超過 25mg/dl，則須做交換輸血治療。

(五) 護理問題

- 1.易受傷害／照光療法。
- 2.體溫恆定失常／周圍環境溫度改變。
- 3.體液容積不足／照光療法。

(六) 護理措施

- 1.易受傷害／照光療法。
 - (1) 以眼罩保護眼睛。
 - (2) 嬰兒與燈的距離（50-60 公分或 16-18 吋）。
 - (3) 注意生命徵象變化。
 - (4) 每兩小時鬆開眼罩，避免眼睛長時間受壓。
 - (5) 觀察黃疸徵象。
- 2.體溫恆定失常／周圍環境溫度改變。
 - (1) 每兩小時翻身一次，使全身照射均勻。
 - (2) 每四小時測量體溫變化，適度調整保溫箱溫度。
 - (3) 每日檢視光源強度。
- 3.體液容積不足／照光療法。
 - (1) 觀察皮膚彈性、尿量。
 - (2) 觀察排便性狀及次數。
 - (3) 視需要補充水分。
 - (4) 每日測量體重。
 - (5) 觀察嬰兒囟門有無凹陷脫水情形。
 - (6) 鼓勵每日哺餵八次。

主題名稱	新生兒黃疸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/6

(七) 衛教指導

1. 尿布疹的照護與預防。
2. 新生兒發燒的處理。
3. 小兒腹瀉的處理。
4. 新生兒黃疸。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 謝武勳、吳美環、陳倩儀(2014)•新生兒黃疸，實用新生兒科醫療手冊(二版，303-308頁)•台北：台大。
- (二) 陳月枝、黃靜微、林元淑、張綠怡、蔡綠蓉、林美華...魏琦芳(2021)•實用兒科護理學(8版)•台北市：華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	新生兒黃疸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定	97 年 11 月 30 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.8.31	2.1	1.修正使用單位範圍 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31	3.1	修正說明內容(六)護理措施及(七)衛教指導部份	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.2	1.新增第三項第(一)目之 3 內容 2.增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	將參考文獻出處呈現於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	新生兒黃疸	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-N05	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.5	1. 修正第三項第一、四目說明內容。 2. 修正第三項第五、六目護理問題。 3. 增修第六項參考文獻資料。 4. 刪除內文參考文獻。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.6	修訂第三項第二、三目說明內容。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.08.07	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	